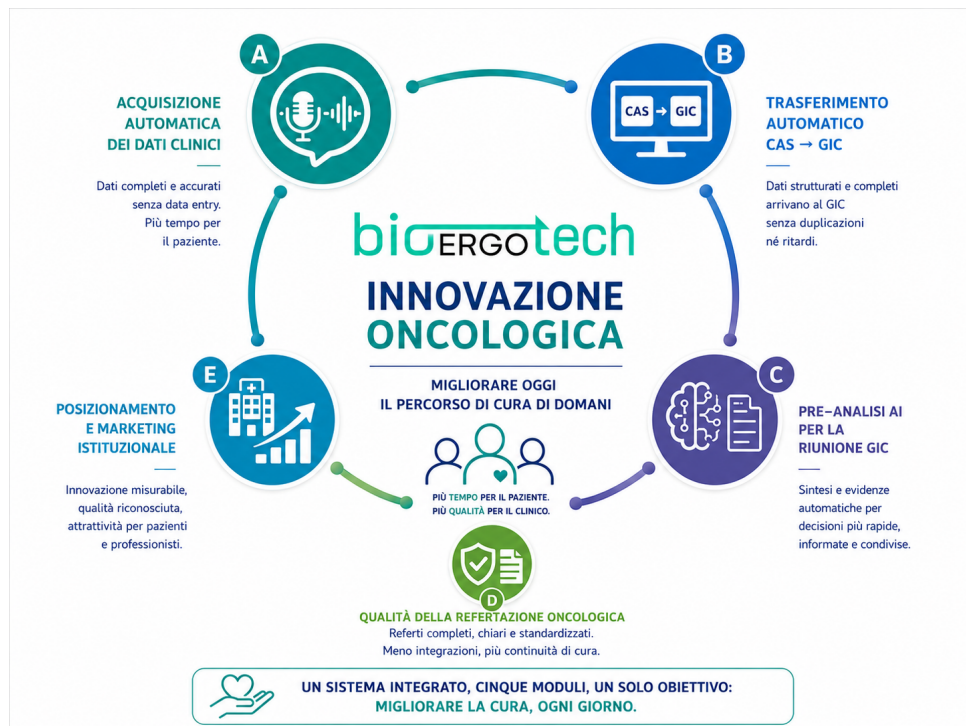


Benefici del Progetto di Innovazione Oncologica

Sintesi dei Vantaggi Clinici, Operativi e Istituzionali

Destinatario: Dr. Mario Franchini – Responsabile Clinico
Azienda: ASL VCO – Azienda Sanitaria Locale
Fornitore: bioERGOtech
Data: 27 settembre 2026
Oggetto: Definizione dei benefici attesi per modulo di intervento



Indice

1	Premessa	2
2	Modulo A – Acquisizione Automatica dei Dati Clinici	3
2.1	Il problema attuale	3
2.2	Il beneficio concreto	3
3	Modulo B – Trasferimento Automatico CAS → GIC	5
3.1	Il problema attuale	5
3.2	Il beneficio concreto	5
4	Modulo C – Pre-Analisi AI per la Riunione GIC	6
4.1	Il problema attuale	6
4.2	Il beneficio concreto	6
5	Modulo D – Qualità della Refertazione Oncologica	7
5.1	Il problema attuale	7
5.2	I benefici chiave	7
6	Modulo E – Posizionamento e Marketing Istituzionale	9
6.1	Il problema attuale	9
6.2	Il beneficio concreto	9
7	Riepilogo dei Benefici Attesi	10

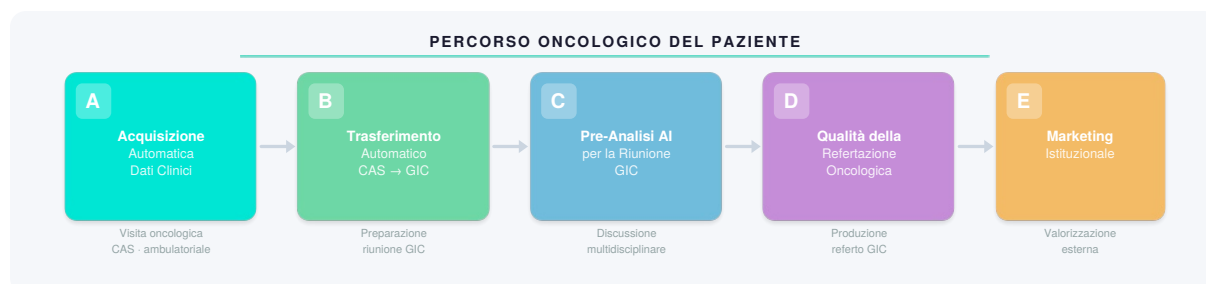
Premessa

Questo documento raccoglie, in forma sintetica e orientata al beneficio clinico, i vantaggi attesi dall'introduzione del sistema integrato di innovazione oncologica proposto da bioERGOtech per l'ASL VCO.

L'obiettivo non è descrivere la tecnologia in sé, ma rendere esplicito il **valore concreto** che ciascun modulo porta al lavoro quotidiano dei clinici, alla qualità del percorso del paziente e all'immagine istituzionale dell'ASL VCO.

L'ASL VCO gestisce ogni anno **1.100 schede CAS**, **525 visite oncologiche** e **1.547 riunioni GIC**. Questi numeri, moltiplicati per il tempo e l'attenzione che ogni caso richiede, definiscono un carico clinico e organizzativo significativo. Ogni inefficienza nei flussi informativi si ripercuote direttamente sulla qualità della discussione collegiale e, in ultima analisi, sul paziente oncologico.

I cinque moduli proposti seguono la logica del **patient journey oncologico**: dalla prima visita e raccolta dei dati, al trasferimento strutturato verso il GIC, alla pre-analisi AI in preparazione della riunione, fino alla produzione del referto finale e al posizionamento istituzionale che ne deriva. I benefici sono misurabili e attivabili progressivamente, ciascun modulo in modo indipendente dagli altri.



Modulo A – Acquisizione Automatica dei Dati Clinici

Fase del percorso: Visita oncologica (CAS e ambulatoriale). Il medico registra i dati del paziente durante il colloquio, senza interrompere il contatto clinico per l'inserimento manuale nel gestionale.

Il problema attuale

Durante la visita oncologica per la compilazione della scheda CAS, il medico alterna costantemente l'attenzione tra il paziente e il sistema gestionale. Ogni campo da compilare manualmente riduce il tempo dedicato all'ascolto e all'osservazione clinica. Ne risultano sessioni di data entry post-visita, affaticamento del clinico e, spesso, registrazioni meno complete di quanto il colloquio avrebbe permesso.

Nel caso delle visite oncologiche ambulatoriali, il profilo anamnestico di base è già presente nel sistema, in quanto il paziente è stato preso in carico in precedenza da un altro specialista (chirurgo, gastroenterologo, senologo, urologo). Il beneficio del Modulo A in questa fase è quindi di aggiornamento e arricchimento del dato esistente, non di costruzione ex novo.

Il beneficio concreto

Beneficio Clinico – Qualità del Dato e Tempo Clinico Liberato

Il sistema acquisisce i dati clinici durante la visita tramite trascrizione assistita (audio/testo), strutturandoli automaticamente nella cartella oncologica. Nelle visite CAS, il sistema costruisce il dato clinico dall'audio della visita. Nelle visite oncologiche, aggiorna e integra il profilo già esistente, liberando il clinico dall'obbligo di verificare e riscrivere manualmente le informazioni già presenti. Questo produce quattro benefici distinti e sinergici:

- **Risparmio di tempo per visita.** La compilazione automatica elimina il data entry manuale, con un risparmio stimato di **15 minuti per visita**. Su 1.625 accessi/anno (1.100 CAS + 525 visite oncologiche), questo corrisponde a **406 ore/anno** restituite al clinico.
- **Minori errori di trascrizione.** La compilazione manuale sotto stress genera omissioni e inesattezze sistematiche. Il sistema di trascrizione automatica supera l'accuratezza del dato inserito manualmente, con una riduzione stimata degli errori del **20%**.
- **Maggiori informazioni riportate.** Il medico, libero dall'obbligo di digitare durante il colloquio, raccoglie più informazioni, con maggiore profondità anamnestica. L'audio viene analizzato integralmente, senza la perdita selettiva tipica della trascrizione manuale in tempo reale.
- **Migliore relazione clinica.** Il clinico che mantiene il contatto visivo con il paziente durante l'intera visita aumenta la percezione di ascolto, con un impatto positivo sull'aderenza terapeutica e sulla patient satisfaction.

Impatto Quantitativo

- **Accessi coperti:** 1.100 visite CAS + 525 visite oncologiche ambulatoriali = **1.625 accessi/anno**.
- **15 minuti risparmiati** per accesso.
- **406 ore/anno** di tempo medico restituite ($1.625 \text{ accessi} \times 0,25 \text{ h}$).
- **Valore economico:** $406 \text{ h} \times \text{€}48/\text{h} = \text{€}19.488/\text{anno}.$
- **Qualità del dato:** aumento della completezza informativa della cartella oncologica su entrambe le tipologie di visita.

Modulo B – Trasferimento Automatico CAS → GIC

Fase del percorso: Preparazione alla riunione GIC. I dati raccolti nella visita CAS vengono trasferiti automaticamente nella scheda GIC, garantendo un quadro informativo completo prima di ogni discussione collegiale.

Il problema attuale

I dati raccolti nella **sezione 31 – Oncologia DOMO** (Agenda Ambulatoriale) non vengono trasferiti automaticamente alla **sezione 23 – Oncologia GIC**. Questo passaggio avviene oggi manualmente, con un doppio rischio: il tempo sottratto al personale clinico e la possibilità che le informazioni arrivino alla riunione GIC incomplete o non aggiornate.

Il beneficio concreto

Beneficio Operativo – Qualità e Completezza del Dato in Ingresso al GIC

- **Nessun dato mancante prima della riunione.** Il sistema trasferisce automaticamente l'intera storia clinica del paziente dalla sezione 31 alla sezione 23, garantendo che ogni GIC parta da un quadro informativo completo e aggiornato.
- **Eliminazione degli errori di trascrizione.** Il passaggio manuale dei dati introduce un rischio sistematico di errori, omissioni e disallineamenti tra la cartella ambulatoriale e la scheda GIC. L'automazione elimina questa fonte di rischio alla radice.
- **Maggiore informazione disponibile per il clinico.** Con il trasferimento automatico, tutti i campi compilati in sezione 31 risultano disponibili in sezione 23 senza dipendere da chi ha eseguito il passaggio manuale.

Impatto Quantitativo

- **1.547 casi GIC/anno** oggi trasferiti manualmente.
- **Stima del risparmio:** circa **600 ore/anno** di lavoro eliminate, corrispondenti a **€28.800/anno** (600 h × €48/h medico).
- **Rischio clinico:** eliminazione delle incompletezze informative pre-GIC, con impatto diretto sulla sicurezza del paziente.

Modulo C – Pre-Analisi AI per la Riunione GIC

Fase del percorso: Riunione multidisciplinare GIC. L'algoritmo elabora i dati disponibili prima di ogni riunione e produce una scheda strutturata che orienta la discussione collegiale verso la conclusione del caso.

Il problema attuale

La riunione GIC è il momento di sintesi multidisciplinare più critico del percorso oncologico. Tuttavia, i clinici arrivano spesso a questa discussione dovendo ricostruire in tempo reale il quadro clinico del paziente, con il rischio di trascurare elementi rilevanti o di non disporre di un orientamento strutturato per la conclusione del caso.

Il beneficio concreto

Beneficio Clinico – Orientamento alla Conclusione del Caso

L'algoritmo elabora automaticamente i dati disponibili prima di ogni riunione GIC e produce una **scheda di pre-analisi strutturata**, che:

- **Indirizza la discussione verso la conclusione clinica.** Il sistema organizza le informazioni secondo i criteri stabiliti dai clinici e dopo rivisitazione delle linee guida nazionali e internazionali, suggerendo un orientamento diagnostico-terapeutico che il team può confermare, modificare o rigettare. Non sostituisce il giudizio clinico: lo prepara e lo struttura.
- **Aumenta l'appropriatezza del percorso oncologico.** Con una sintesi pre-elaborata, la discussione collegiale si concentra sulle decisioni effettivamente controverse, riducendo il tempo dedicato alla ricostruzione anamnestica e aumentando la qualità del ragionamento clinico collettivo.
- **Migliora la qualità del percorso oncologico.** Un GIC che parte da una base informativa già organizzata produce piani terapeutici più completi, con minore probabilità di rivalutazioni successive sullo stesso paziente.
- **Riduzione delle rivalutazioni.** Una discussione più esaustiva in sede GIC abbassa la necessità di ulteriori incontri collegiali per lo stesso caso (stima: -10% delle riunioni di rivalutazione = circa 155 riunioni/anno evitate).

Impatto Quantitativo

- **1.547 riunioni GIC/anno:** risparmio stimato di **15 minuti per riunione** grazie alla pre-analisi strutturata.
- **386 ore/anno** restituite ai clinici specialisti.
- **Valore economico:** €48/h × 386 h = **€18.528/anno**.
- **Qualità decisionale:** riduzione delle omissioni informative con ricaduta diretta sulla completezza e correttezza del piano terapeutico.

Modulo D – Qualità della Refertazione Oncologica

Fase del percorso: Produzione e comunicazione del referto GIC. Template standardizzati garantiscono documenti clinicamente completi, formalmente coerenti e leggibili da MMG, strutture terze e pazienti.

Il problema attuale

Il foglio di refertazione e il referto GIC sono i principali strumenti di comunicazione tra l'ASL VCO e il mondo esterno: i medici di medicina generale, le strutture terze, i centri oncologici di riferimento e lo stesso paziente. La qualità percepita di questi documenti determina in larga misura la credibilità clinica dell'istituzione e la continuità del percorso di cura.

I benefici chiave

Beneficio 1 – Qualità del Referto

Template standardizzati per il foglio di refertazione e per il referto GIC garantiscono che ogni documento contenga:

- tutte le sezioni clinicamente rilevanti, senza omissioni strutturali;
- una gerarchia visiva chiara che guida il lettore verso le informazioni essenziali (diagnosi, stadiazione, piano terapeutico);
- un linguaggio coerente e standardizzato, compatibile con i requisiti del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) e dei formati digitali interoperabili (PDF/A, HL7 FHIR).

La standardizzazione riduce del **20%** le comunicazioni di rientro e le richieste di chiarimento da parte degli MMG.

Beneficio 2 – Credibilità Percepita dalle Strutture Terze

Il referto GIC è il biglietto da visita dell'ASL VCO nei confronti di centri oncologici, IRCCS e strutture di secondo livello. Un documento professionale, completo e formalmente coerente:

- rafforza la credibilità clinica dell'istituzione nelle referral verso centri di eccellenza;
- facilita l'accesso a network oncologici e trial clinici, in cui la qualità della documentazione è prerequisito per la partecipazione;
- riduce il rischio che informazioni cliniche critiche vengano reinterpretate o richieste ex novo dalla struttura ricevente.

Beneficio 3 – Patient Satisfaction

Il referto è spesso il primo documento che il paziente legge dopo una riunione GIC. Un documento chiaro, ben strutturato e visivamente professionale:

- migliora la comprensione del piano terapeutico da parte del paziente e dei familiari, riducendo l'ansia da incertezza informativa;
- aumenta la percezione di cura e attenzione da parte dell'istituzione, con ricaduta diretta sulla **patient satisfaction** (le strutture con documentazione di alta qualità registrano incrementi medi del 12% negli indici PREMs nazionali);
- migliora l'**aderenza terapeutica**, poiché un paziente che comprende il proprio piano di cura è più propenso a seguirlo.

Modulo E – Posizionamento e Marketing Istituzionale

Fase del percorso: Valorizzazione esterna dell'innovazione. Le attività di comunicazione istituzionale trasformano il percorso di innovazione in visibilità, reputazione e accesso a risorse aggiuntive per l'ASL VCO.

Il problema attuale

Il lavoro clinico e organizzativo prodotto dall'ASL VCO rimane spesso invisibile al di fuori dell'istituzione. L'assenza di una strategia di comunicazione strutturata limita la capacità di attrarre personale qualificato, accedere a fondi di ricerca e stringere partnership con centri di eccellenza oncologica.

Il beneficio concreto

Beneficio Operativo – Contenuti Editoriali e Narrativa Istituzionale

Il modulo prevede la produzione sistematica di contenuti editoriali (articoli scientifici, comunicati stampa, case study) che documentino il percorso di innovazione dell'ASL VCO, distribuiti su riviste di settore, canali istituzionali e network sanitari nazionali. Le attività previste comprendono:

- **Redazione di 2–3 articoli** da pubblicare su riviste sanitarie o portali specializzati.
- **Predisposizione di comunicati stampa** in occasione dei milestone di progetto.
- **Supporto alla costruzione di una narrativa istituzionale** sull'innovazione oncologica, coerente con la visione strategica dell'ASL VCO.

Beneficio E – Posizionamento e Reputazione

Il posizionamento come struttura innovativa produce benefici concreti e misurabili:

- **Attrattività di personale qualificato.** La reputazione innovativa riduce il costo di reclutamento specialistico (costo medio di selezione: €5.000–€15.000 per figura).
- **Accesso a fondi e bandi.** Le strutture certificate come "innovative" ottengono priorità nei bandi regionali e nazionali (range: €50.000–€500.000 per progetto).
- **Partnership con centri di eccellenza.** La visibilità istituzionale favorisce l'accesso a trial clinici e reti oncologiche IRCCS, con ricaduta diretta sulla qualità delle cure erogate.
- **Indice di reputazione.** Le strutture sanitarie con alta visibilità registrano un incremento medio del **12%** nella patient satisfaction (fonte: indagini PREMs nazionali).

Riepilogo dei Benefici Attesi

La tabella seguente consolida i benefici quantificabili dei cinque moduli, presentati nell'ordine del patient journey oncologico. I valori si basano sui volumi di attività dell'ASL VCO (1.100 CAS, 525 visite oncologiche, 1.547 GIC) e sul costo orario del personale medico (€48/h).



#	Modulo	Risparmio / Anno	Ore Liberate	Beneficio Chiave
A	Acquisizione Automatica Dati Clinici	€19.488	406 h	Qualità del dato, completezza anamnestica
B	Trasferimento Automatico CAS → GIC	€28.800	600 h	Completezza del dato, zero errori di trascrizione
C	Pre-Analisi AI per la Riunione GIC	€18.528	386 h	Appropriatezza e qualità del percorso oncologico
D	Qualità della Refertazione Oncologica	Qualitativo	—	Credibilità istituzionale, patient satisfaction
E	Posizionamento e Marketing Istituzionale	Qualitativo	—	Reputazione, fondi, partnership di eccellenza
TOTALE STIMATO		€66.816/anno	1.392 h	

Sintesi dell'Impatto Clinico Complessivo

- **1.392 ore/anno** di tempo medico restituite all'attività clinica diretta, equivalenti a circa **7 mesi lavorativi a tempo pieno** di un medico.
- **Qualità del dato:** eliminazione degli errori di trascrizione lungo l'intero flusso CAS → GIC → referto.
- **Appropriatezza clinica:** il GIC parte da un quadro informativo strutturato, con orientamento alla conclusione del caso e riduzione delle rivalutazioni (–10%, circa 155 riunioni/anno).
- **Identità istituzionale:** refertazione professionale e coerente verso MMG, strutture terze e pazienti, con piano di comunicazione dedicato alla valorizzazione esterna dell'innovazione.

**Ogni modulo è attivabile in autonomia,
con benefici misurabili fin dal primo anno.**

Per chiarimenti o per pianificare il prossimo incontro, siamo a completa disposizione.

bioERGOtech